

社区抗血小板和抗凝药物的综合合理用药

▲中华医学会 钱宁(整理)

由于心脑血管疾病在社区越来越多见,社区医师也经常会接触到抗血小板和抗凝药物,本讲我们将结合 2009 年国家基本药物目录,介绍抗血小板和抗凝药物的综合合理用药。

社区主要抗血小板和抗凝药物种类

阿司匹林 阿司匹林已经被列入国家基本药物目录,在抗血小板方面主要用于预防血栓形成。

双嘧达莫 双嘧达莫已经被列入国家基本药物目录。主要用于抗血小板聚集和预防血栓形成。

氯吡格雷 氯吡格雷未被列入国家基本药物目录。主要用于预防和治疗因血小板高聚集

状态引起的心、脑疾病及其他动脉的循环障碍疾病。

曲克芦丁(维脑路通) 曲克芦丁未被列入国家基本药物目录。主要用于脑血栓形成和脑梗死所致的偏瘫、失语以及心肌梗死前综合征、动脉硬化、中心性视网膜炎、血栓性静脉炎等。

表 1 社区主要的抗血小板药物

种类	国家基本药物目录中药物	其他
阿司匹林	阿司匹林	无
双嘧达莫	双嘧达莫	无
氯吡格雷	无	氯吡格雷
曲克芦丁	无	曲克芦丁

社区主要抗凝药物种类

由于口服的华法林和新抗凝都需要定期监测凝血时间及其国际标准化比率 (INR),在社区一般做不到这些,所以在本文不做介绍,主要介绍不能口服需要注射的肝素与低分子肝素。

肝素 肝素(钠)已经被列入国家基本药物目录。主要用于血

栓形成后栓塞性疾病。

低分子肝素 低分子肝素未被列入国家基本药物目录。主要用于预防末梢血管病变,不稳定心绞痛和非 Q 波心肌梗死或脑梗死等。

表 2 社区主要的抗凝药物

种类	国家基本药物目录中药物	其他
肝素	肝素	无
低分子肝素	无	法安明、克赛、速避凝等

主要抗血小板和抗凝药物的综合合理使用

阿司匹林 除注意本品的不良反应(如胃肠道反应、出血、过敏等)外,社区使用时还要注意的是:胃肠道反应较为多见,可能发生胃肠道出血或溃疡; <2 岁儿童、孕妇和哺乳期妇女禁用;与抗凝药物合用时可增加出血的风险;与糖皮质激素合用时可增加胃肠道的不良反应。

双嘧达莫 除注意本品的不良反应(如头晕头痛、过敏、呕吐腹泻等)外,社区使用时还要注意的是:本品与抗凝剂、抗血小板药合用时应注意出血倾向,与阿司匹林有协同作用;有出血倾向、低血压及儿童、孕妇不宜使用;可能加重严重冠脉病变。

氯吡格雷 除注意本品的不良反应(如腹痛、消化不良、过敏等)外,社区使用时还要注意的是:对本品过敏、近期有活动性出血者禁用;需要手术、肝脏损伤、有出血倾向者及儿童、孕妇和哺乳妇女应慎用;增加阿司匹林对胶原引起的血小板聚集的抑制效

果,和替普生合用,胃肠潜血损失增加。

曲克芦丁 除注意本品的不良反应(如恶心、便秘等)外,社区使用时还要注意的是:对本品过敏者禁用;妊娠与哺乳期妇女禁用,要定期复查肝功能;用药期间避免阳光直射、高温及过久站立。

肝素 除注意本品的不良反应(如自发性出血、过敏、骨质疏松等)外,社区使用时还要注意的是:有自发性出血倾向、凝血功能障碍、溃疡病、创伤、产后出血及严重肝功能不全者禁用;与香豆素及其衍生物、非甾体消炎药、双嘧达莫、右旋糖苷、糖皮质激素、尿激酶、链激酶等合用可增加出血危险;肝素中毒时可用 1%的硫酸鱼精蛋白溶液缓慢静滴。

低分子肝素 除注意本品的不良反应(如出血、过敏、血小板减少等)外,社区使用时还要注意的是:肝转氨酶可一过性增高;对本品过敏者和妊娠与哺乳期妇女禁用;不可经肌肉注射给药。

● 专家点评

部分危及生命的药物相互作用(四)

▲352100 福建省宁德人民医院 李枝端

地高辛 + 阿普唑仑

地高辛适应证 用于高血压、瓣膜性心脏病、先天性心脏病等急慢性心功能不全。尤其适用于伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全;用于控制伴有快速心室率的心房颤动、心房扑动患者的心室率及室上性心动过速。对于肺源性心脏病、心肌严重缺血、活动性心肌炎及心外因素,如严重贫血、甲状腺功能低下及维

生素 B₁ 缺乏症的心功能不全疗效差。

阿普唑仑适应证 主要用于治疗焦虑、紧张、激动,也可作为催眠或焦虑的辅助用药、抗惊恐药,并能缓解急性酒精戒断症状。对精神抑郁患者应慎用。

相互作用 阿普唑仑与地高辛合用,可增加地高辛血药浓度而致中毒。

布洛芬 + 锂盐

布洛芬适应证 本品为非甾体抗炎药,适用于缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作或持续性的关节肿痛症状,无病因治疗及控制病程的作用。治疗非关节性的各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;急性轻、中度疼痛,如手术后、创伤后、劳损后、原发性痛经、牙痛、头痛等;对成人和儿童的发热有解热

作用。

碳酸锂适应证 主要治疗躁狂症,对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防复发作用;对反复发作的抑郁症也有预防作用;也用于治疗分裂-情感性精神病。

相互作用 锂盐的治疗指数低,治疗量和中毒量较接近。碳酸锂与非甾体抗炎药(如布洛芬、吲哚美辛)、乙醇和大多数抗精神病药合用,可使血锂浓度升高,增加锂的毒性。

地高辛 + 伊曲康唑

伊曲康唑适应证 适用于治疗以下疾病:①妇科:外阴阴道念珠菌病;②皮肤科/眼科:花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病,由皮肤癣菌和(或)酵母菌引起的甲真菌病;③系统性真菌感染:系统性曲霉病

及念珠菌病、隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎)、组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、芽生菌病和其他各种少见的系统性或热带真菌病。

相互作用 已报道伊曲康唑与华法林和地高辛有相互作用。

地高辛 + 奎尼丁

奎尼丁适应证 主要适用于心房颤动或心房扑动经电转复后的维持治疗。对房性早搏、阵发性室上性心动过速、预激综合征伴室上性心律失常、室性早搏、室性心动过速有效,并有转复心房颤

动或心房扑动的作用,但由于不良反应较多,目前已少用。肌注及静注已不再使用。

相互作用 地高辛与奎尼丁合用,可使本品血药浓度提高 1 倍,提高程度与奎尼丁用量相关,

地高辛 + 红霉素

红霉素适应证 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药:溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎,溶血性链球菌所致猩红热、蜂窝织炎,白喉及白喉带菌者,气性坏疽、炭疽、破伤风,

放线菌病,梅毒,李斯特菌病等。其他还有军团菌病,肺炎支原体肺炎,肺炎衣原体肺炎,衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染,沙眼衣原体结膜炎,淋病奈瑟菌感染,厌氧菌所致口腔感染,空肠弯曲菌肠炎,百日咳。

因此这些药物若与本品同时服时,应减少剂量。

伊曲康唑(斯皮仁诺) 在使用本品治疗期间需监测血浆浓度、药物作用及不良反应的药物,当与伊曲康唑合用时,必要时应当减量。

甚至可达到中毒浓度,即使停用

地高辛,其血药浓度仍继续上升,这是奎尼丁从组织结合处置换出地高辛,减少其分布容积之故。两药合用时,应酌减地高辛用量 1/2~1/3。

相互作用 红霉素与地高辛合用会增加后者的血药浓度,甚至达到中毒水平。

因此,建议同时服用地高辛和红霉素的患者要进行临床与心电图的监测,必要时调整地高辛的用量。